

CAPÍTULO 12.7

Cefaleas Crónicas

PERFIL EUNACOM 1.10.1.014

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Temblor, Parkinson y Síndromes Extrapiramidales

Tipos de Temblor

TABLA 12.7.1: TIPO VS CUÁNDO APARECE				
TIPO	CUÁNDO APARECE	CARACTERÍSTICAS	CAUSA	TRATAMIENTO
Esencial	Al adoptar postura o tomar objetos	Bilateral, simétrico; puede afectar la cabeza y voz; empeora con la edad	Idiopático (familiar)	Propranolol
Parkinson	En reposo	Asimétrico; desaparece al tomar el objeto	Degenerativa (dopaminérgica)	Levodopa / carbidopa
Cerebeloso (dismetría)	Con intención de movimiento	Empeora al acercarse al objetivo; no tiembla en reposo	Lesión cerebelosa	Tratar causa

Enfermedad de Parkinson

Triada clásica

- **Temblor de reposo** (asimétrico, "cuenta monedas")
- **Rigidez** ("en rueda dentada")
- **Bradicinia** (movimientos lentos)

Síntomas asociados

- Hipomimia (cara inexpressiva)
- Pérdida del braceo al caminar
- Disminución del pestañeo
- Marcha festinante (pasos pequeños, arrástro)

Diagnóstico

- **Clínico** (no se necesita imagen ni examen de laboratorio)

Tratamiento

- **Levodopa + carbidopa** (agonistas dopaminérgicos) — de elección
- En etapas tardías: puede aparecer **demencia** → si la demencia es el síntoma inicial → pensar en **Demencia por cuerpos de Lewy**

Síndrome Cerebeloso

TABLA 12.7.2: SIGNO VS DESCRIPCIÓN	
SIGNO	DESCRIPCIÓN
Dismetría	Temblor de intención (al acercarse al objeto)
Adiadococinesia	No puede hacer movimientos alternantes rápidos
Ataxia	Marcha "de borracho" (inestable, base amplia)
Nistagmo multidireccional	Vértigo central

- **Latencia ipsilateral** al lado de la lesión (≠ cerebro = contralateral)
- **Diagnóstico:** RNM (buscar causa: tumor, AVE, EM) - **Cerebelitis postvariela** = transitoria, solo educar

Extrapiramidalismos por Fármacos

Drogas causantes: antipsicóticos (haloperidol, risperidona, quetiapina) y antieméticos (metoclopramida, domperidona, cisaprida) → **antidopaminérgicos**

TABLA 12.7.3: SÍNDROME VS CLÍNICA

SÍNDROME	CLÍNICA	TIEMPO DE INICIO	TRATAMIENTO
Parkinsonismo	Triada de Parkinson (temblor, rigidez, bradicin.)	Días-semanas	Suspender fármaco
Distonía aguda	Contractura muscular dolorosa: torticolis espástica, trismo, crisis oculógira	Primeras horas-días	Suspender fármaco + benzodicepinas EV (lorazepam/diazepam)
Acatisia	Inquietud, necesidad de mover las piernas (movimiento voluntario)	Días-semanas	Suspender o ↓ dosis + propranolol o BZD
Disquinesia tardía	Movimientos reptantes de boca/lengua/cara → luego extremidades	Meses-años de uso	Suspender precozmente; daño puede ser permanente

Corea

TABLA 12.7.4: TIPO VS CAUSA		
TIPO	CAUSA	CARACTERÍSTICAS
Menor (Sydenham)	Fiebre reumática	Transitoria; criterio mayor de Jones
Mayor (Huntington)	Genética (autosómico dominante, cromosoma X)	Incurable; evoluciona a demencia

Síndrome Neuroléptico Maligno (SNM)

- **Triada: hipertonía + hipertermia + compromiso de conciencia**
- **Desencadenante:** inicio o aumento de dosis de antipsicótico
- **Tratamiento:**
 - 1. Suspender el antipsicótico
 - 2. Medidas físicas (ABC)
 - 3. Benzodicepinas (para la rigidez)
 - 4. **Dantroleno** (relajante muscular de elección)

Vs. Hipertermia Maligna

TABLA 12.7.5: CLASIFICACIÓN Y CRITERIOS CLÍNICOS		
	SNM	HIPERTERMIA MALIGNA
Desencadenante	Antipsicótico	Anestesia (succinilcolina o gases halogenados)
Clínica	Igual	Igual

| Tratamiento | Igual | Dantroleno (es el específico) |

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM**ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:**

"Paciente de 30 años consulta por cefalea periocular derecha muy intensa, de carácter lancinante, asociada a miosis, lagrimeo y rinorrea del mismo lado. Refiere que ha tenido 3 episodios similares en la última semana. ¿Cuál es el tratamiento de la crisis?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Cefaleas Crónicas. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- Diagnóstico de cefaleas crónicas es CLÍNICO. No requieren TAC salvo signos de alarma (incluye cambio en patrón habitual).
- Migraña: pulsátil, frontoparietal/retroocular, sonofobia/fotofobia, posible aura. Cefalea tensional: opresiva, occipital/cintillo, irradiada a cuello.
- Cluster: lancinante periocular unilateral + miosis + ptosis + ojo rojo superficial + epífora + rinorrea. NO confundir con glaucoma agudo (midriasis + ojo rojo profundo).
- Crisis de cluster: oxígeno 100% + triptanes subcutáneos. NO sirven paracetamol, AINEs ni ergotamínicos orales.
- Neuralgias: primaria (examen neurológico normal → carbamazepina) vs secundaria (examen alterado → neuroimagen buscando causa).
- Profilaxis migraña (>2 crisis/mes): ácido valproico, amitriptilina, flunaricina o propranolol. Profilaxis tensional (>2/semana): igual sin propranolol.
- Ergotamínicos máximo 2 veces/semana. Abuso genera cefalea de rebote. Tratamiento: suspender + analgésicos alternativos.
- Estatus migrañoso: escalonado → AINEs + triptanes → metoclopramida/corticoides → sedación → antipsicóticos.

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (CEFALEAS CRÓNICAS)**PREGUNTA 1**

Paciente de 30 años consulta por cefalea periocular derecha muy intensa, de carácter lancinante, asociada a miosis, lagrimeo y rinorrea del mismo lado. Refiere que ha tenido 3 episodios similares en la última semana. ¿Cuál es el tratamiento de la crisis?

- A)** Paracetamol 1g vía oral
- B)** Ergotamina vía oral
- C)** Oxígeno al 100% y sumatriptán subcutáneo
- D)** Ketorolaco intramuscular
- E)** Carbamazepina vía oral

PREGUNTA 2

Paciente de 50 años presenta dolor en la cara tipo eléctrico, en la zona de la mejilla y dientes superiores, que se desencadena al afeitarse. El examen neurológico muestra hipostesia facial. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- A)** Iniciar carbamazepina y control ambulatorio
- B)** Solicitar resonancia magnética buscando causa secundaria
- C)** Indicar oxígeno al 100% por probable cluster
- D)** Derivar a odontología por dolor dentario
- E)** Iniciar amitriptilina nocturna

PREGUNTA 3

Paciente con migraña crónica refiere que usa ergotamina diariamente desde hace 3 meses y que la cefalea ha empeorado progresivamente. ¿Cuál es el diagnóstico y la conducta?

- A)** Migraña refractaria; aumentar dosis de ergotamina
- B)** Cefalea por abuso de ergotamínicos; suspender ergotamina y dar analgésicos alternativos
- C)** Tumor cerebral; solicitar RM con contraste
- D)** Estatus migrañoso; hospitalizar para manejo escalonado
- E)** Cefalea tensional sobreagregada; agregar propranolol

RESUMEN: CEFALÉAS CRÓNICAS

Esta clase cubre las cefaleas crónicas: migraña/jaqueca, cefalea tensional, cefalea en racimos (cluster/Horton), neuralgia del trigémino y otras neuralgias. El diagnóstico es absolutamente clínico y no requieren TAC salvo signos de alarma (incluyendo cambio en la clínica habitual). El tratamiento tiene dos componentes: crisis y profilaxis. La migraña es pulsátil/opresiva, frontoparietal/retroocular, con sonofobia, fotofobia y posible aura (escotoma centelleante). La cefalea tensional es opresiva, occipital/en cintillo, irradiada a músculos del cuello. La cefalea cluster es lancinante periocular unilateral con miosis, ptosis, ojo rojo superficial, rinorrea y epífora, que viene en racimos y se desencadena por alcohol. Para el tratamiento de crisis: la tensional responde a paracetamol/AINEs; la migraña a AINEs + triptanes/ergotamínicos; el cluster NO responde a nada habitual, requiere oxígeno al 100% y triptanes subcutáneos. La profilaxis de tensional y migraña usa ácido valproico, amitriptilina, flunaricina (y propranolol para migraña). Profilaxis del cluster: corticoides (máximo 3 semanas) y verapamilo. Las neuralgias (trigémino, Arnold, glossofaríngeo) se caracterizan por dolor eléctrico/en ramalazo. Si el examen neurológico es normal = primaria (carbamazepina). Si está alterado = secundaria (neuroimagen buscando tumor). Se aborda también el estatus migrañoso y la cefalea por abuso de ergotamínicos.